

Il vostro adolescente autistico

Per genitori e assistenti familiari — sostenere un adolescente autistico (circa 12–18 anni).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione del/della vostro/a adolescente si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi. L'adolescenza accumula domande ad alto canale — regole tra pari che cambiano, frequentazioni, cambiamenti del corpo, esami — su un sistema che trova costoso il cambio rapido. Questa è l'**età di picco per ansia, depressione e burnout**, e molti adolescenti autistici (specialmente ragazze e generi marginalizzati) vengono **identificati solo in crisi**. I loro interessi intensi sono identità, regolazione e recupero — non problemi. Il vostro compito passa dal gestire all' *accompagnare*: seguite la loro guida, proteggete il loro focus, abbassate il carico e prendete sul serio la loro vita interiore.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Esausto/a, ritirato/a, „non ha voglia”; rifiuta la scuola	Probabile burnout autistico o sovraccarico — distinto dalla depressione e dalla pigrizia
Interessi intensi; resiste a rinunciarvi	Gli interessi sono identità, regolazione e recupero — non ossessioni
„Bene” tutto il giorno, crolla dietro una porta chiusa	Forte camuffamento ; il costo si paga dopo, a casa
Autolesionismo, pensieri oscuri, o crisi	Rischio reale ed elevato in questo gruppo; spesso il primo segnale di un bisogno non soddisfatto
Lento a iniziare/cambiare; non risponde alle domande	Inerzia autistica + tempo di elaborazione, non maleducazione o „non gli importa”

Provate questo

- **Protegete e validate i loro interessi** — mai limitare una passione sana; è il loro principale regolatore e una via verso studio, amici e recupero.
- **Fate spazio per togliere la maschera a casa** — casa è il luogo sicuro dove la maschera della giornata scolastica finalmente cade. Aspettatevi un crollo doposcuola; inserite tempo calmo, a bassa richiesta e basato sugli interessi.
- **Abbassate le richieste quando il serbatoio è vuoto**. Se sono in burnout, la mossa supportata dalle evidenze è **ridurre le aspettative e ripristinare riposo e interessi** — non spingere di più.
- **Comunicare in modo letterale, una cosa alla volta**, spesso per iscritto o per messaggio; concedete tempo di elaborazione; rispettate la loro autonomia nelle decisioni.
- **Chiedete direttamente** di umore, ansia, sonno e pensieri suicidari con domande concrete — e ascoltate la risposta.
- **Sostenete la scuola** (referente SEN/SEND, PEI/PDP, uno spazio quieto, meno transizioni) e pianificate presto il passaggio ai servizi per adulti.

Evitate questo

- Confondere **il burnout autistico con la depressione** — trattarlo come „sforzati di più” può approfondirlo e aumentare il rischio di suicidio.
- Premere perché mascherino, facciano contatto visivo o „siano più sociali” come obiettivo.
- Accumulare attività, piani sociali e aspettative quando sono già esausti.

Quando serve altro supporto

Il burnout autistico è reale, grave e distinto — esaurimento cronico, perdita di abilità e ridotta tolleranza agli stimoli; può durare mesi ed è collegato a pensieri suicidari. Le co-occorrenze **ansia, depressione, ADHD (AuDHD), disturbi del sonno e alimentari** sono comuni e meritano cure informate sull'autismo. Cercate un clinico positivo sull'autismo, gruppi tra pari e mentori — l'amicizia di qualità protegge potentemente.

Se l'adolescente è una ragazza o un genere marginalizzato

Il camuffamento raggiunge qui il picco e genera gran parte delle diagnosi mancate e del costo sulla salute mentale. L'adolescente „ansioso/a, perfezionista, socialmente abile in superficie” può essere un/a giovane autistico/a esausto/a. Chiedete specificamente dell'**esaurimento da mascheramento** e prendete sul serio uno schema di differenze di tutta la vita.

Informazioni su questa guida

*Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parti 1 e 4) e la sintesi sul **Monotropismo**, con la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parte 3.3). Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico.** Conoscete il/la vostro/a adolescente meglio di chiunque altro; adattate questo a lui/lei.*

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Pearson & Rose (2021, mascheramento); Bradley et al. (2021, camuffamento); Edgar (2024). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.